



THE ULTIMATE ACADEMY



GUIDE

ANTI-BLESSURE

Prévenir, détecter et soigner
les blessures du coureur

 6 Blessures

 10 Exercices

 Étirements

 Protocoles

THEULTIMATEACADEMY.FR

Sommaire

Introduction	3
Les 6 blessures courantes	4
Programme de renforcement — Partie 1	5
Programme de renforcement — Partie 2	6
Étirements essentiels	7
Gestion de la charge d'entraînement	8
Protocole PEACE & LOVE	9
Chaussures et matériel	10
Passer à l'action	11



Introduction

Courir, c'est l'une des activités les plus naturelles et accessibles qui soit. Pourtant, les statistiques sont sans appel : **près de 65% des coureurs se blessent chaque année**, souvent pour des raisons qui auraient pu être évitées avec un peu de méthode.

65%

des coureurs se
blessent chaque
année

3×

plus lent :
l'adaptation des
tendons vs muscles

10%

d'augmentation de
charge maximum
par semaine

2×

plus de risques avec
moins de 7h de
sommeil



Progression trop rapide

L'erreur la plus fréquente. Le corps a besoin de temps pour s'adapter : les tendons, os et articulations s'adaptent 3 fois plus lentement que les muscles. Le corps peut sembler "en forme" alors que les structures passives sont déjà en surcharge.



Manque de renforcement

Un coureur qui ne fait que courir accumule des déséquilibres musculaires dangereux. Les fessiers, les tibias antérieurs et le gainage sont souvent trop faibles pour protéger efficacement les genoux, les hanches et les chevilles lors des impacts répétés.



Récupération sous-estimée

La performance et l'adaptation se construisent pendant le repos, pas pendant l'effort. C'est lors du sommeil que le corps répare les micro-lésions et renforce les tissus. Moins de 7h de sommeil par nuit multiplie par deux le risque de blessure selon les études.



Équipement inadapté

Une chaussure usée après 800 km ou mal adaptée à ta morphologie peut créer des douleurs chroniques sur toute la chaîne cinétique : pied, cheville, genou, hanche et dos. La rotation de deux paires différentes réduit de 40% le risque de blessure.

Ce guide est le fruit d'années d'expérience sur le terrain avec des coureurs de tous niveaux. Les protocoles présentés ici sont issus des **dernières recherches en médecine du sport** et adaptés à la réalité de l'entraînement quotidien. L'objectif n'est pas de te faire peur, mais de te donner les outils concrets pour rester sur les routes le plus longtemps possible et progresser **sans interruption forcée**.

Les 6 blessures courantes



Périostite tibiale

Syndrome de stress du tibia

SYMPTÔMES

Douleur diffuse le long du tibia, aggravée à l'effort et en début de séance.

PRÉVENTION

Progression de 10% max/semaine. **Renforcement du mollet** et tibialis. Varier les surfaces.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace 15 min x3/j. Reprise progressive sur surfaces souples.

Fréquente chez les débutants



Tendinite d'Achille

Tendinopathie du tendon calcanéen

SYMPTÔMES

Raideur matinale au talon, douleur à la palpation, gonflement possible.

PRÉVENTION

Montées excentriques sur marche, échauffement soigneux, semelles adaptées.

TRAITEMENT

Repos 2 à 4 semaines, massage transverse profond, kinésithérapie précoce.

Coueurs confirmés



Syndrome de l'essuie-glace

Bandelette ilio-tibiale (BIT)

SYMPTÔMES

Douleur vive sur la face externe du genou, surtout après 20 à 30 min d'effort.

PRÉVENTION

Renforcement des fessiers et abducteurs. Foam roller BIT. Cadence 170-180 pas/min.

TRAITEMENT

Stop si douleur vive. Anti-inflammatoires, étirements spécifiques BIT.

Longue distance



Claquage musculaire

Déchirure de fibre ou de faisceau

SYMPTÔMES

Douleur brutale type "coup de couteau", contracture, hématome possible.

PRÉVENTION

Échauffement progressif 15 min minimum. Hydratation et alimentation soignées.

TRAITEMENT

Protocole PEACE & LOVE (p.9). Arrêt immédiat, pas de chaleur les 72 premières heures.

Séances intenses



Fasciite plantaire

Aponévrosite plantaire

SYMPTÔMES

Douleur intense sous le pied au réveil ou en début de séance, talon et voûte.

PRÉVENTION

Renforcement intrinsèque du pied, billes sous le pied, semelles si besoin.

TRAITEMENT

Étirements du fascia et du mollet, botte de nuit, ondes de choc si chronique.

Route et piste



Syndrome fémoro-patellaire

Genou du coureur

SYMPTÔMES

Douleur sous ou autour de la rotule, en descente et en position assise prolongée.

PRÉVENTION

Squats et fentes unilatéraux, travail de la hanche, réduction du volume.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace, kiné pour rééquilibrage musculaire, taping rotulien si besoin.

Tous niveaux

Programme de renforcement

2 séances/semaine suffisent pour construire une armure musculaire solide. Ces exercices ciblent les zones les plus sollicitées en course. Respecte le temps de récupération entre les séries : 60 à 90 secondes.



01

Squat unilatéral

Quadriceps · fessiers · stabilisateurs

3 × 12 reps

Debout sur une jambe, descends lentement jusqu'à 90°. Garde le genou dans l'axe du pied. Remonte en contrôlant.

Conseil : Variation avancée : squat bulgare avec pied arrière surélevé sur banc



02

Hip thrust

Grand fessier · ischio-jambiers

3 × 15 reps

Dos sur banc, pieds à plat, pousse le bassin vers le haut en contractant fort les fessiers. Pause 1 sec en haut.

Conseil : Essentiel pour prévenir toutes les blessures au genou et à la hanche



03

Mollet excentrique

Soléaire · gastrocnémien · Achille

3 × 15 lentes

Sur une marche, monte sur les deux pieds puis redescends lentement sur une seule jambe en 4 secondes.

Conseil : Prophylaxie numéro 1 contre la tendinite d'Achille — à faire chaque semaine



04

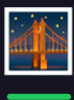
Fente marchée

Quadriceps · fessiers · soléaire

3 × 10/côté

Pas en avant, genou avant à 90°, genou arrière effleure le sol. Pousse sur le talon avant pour remonter.

Conseil : Améliore l'équilibre dynamique et la proprioception globale du coureur



05

Pont fessier

Grand fessier · core · ischios

3 × 20 reps

Allongé dos au sol, genoux fléchis à 90°, pousse le bassin vers le haut. Tiens 2 sec en haut, redescends lentement.

Conseil : Version avancée : une jambe tendue à l'horizontale, alternance gauche/droite

Programme de renforcement



06

Clam shell

Moyen fessier · abducteurs

3 × 20/côté

Allongé sur le côté, hanches fléchies à 60°. Ouvre et ferme le genou supérieur comme une palourde. Lent et contrôlé.

Conseil : Idéal pour prévenir le syndrome de l'essuie-glace et les douleurs de hanche



07

Planche latérale

Obliques · carré des lombes · abducteurs

3 × 30 sec

Sur l'avant-bras, corps aligné des pieds à la tête. Hanches hautes, ne laisse pas la hanche s'affaisser.

Conseil : Progression : planche latérale avec levée de jambe supérieure, 15 reps



08

Tibialis raise

Tibial antérieur · extenseurs des orteils

3 × 20 reps

Dos contre un mur, talons à 30 cm du mur. Lève la pointe des pieds vers le haut en gardant les talons au sol. Mouvement lent et contrôlé.

Conseil : Prévention directe et très efficace contre la périostite tibiale



09

Copenhagen plank

Adducteurs · core · stabilisateurs

3 × 20 sec

Planche latérale avec pied supérieur posé sur un banc. Soulève la hanche inférieure pour créer un pont. Respire normalement.

Conseil : Un des meilleurs exercices de prévention toutes catégories confondues



10

Chaise au mur

Quadriceps · genou · isométrique

3 × 45 sec

Dos contre le mur, genoux à 90°. Tiens la position sans bouger. La brûlure dans les quadriceps est tout à fait normale.

Conseil : Excellent pour renforcer la rotule et prévenir le syndrome fémoro-patellaire

Étirements essentiels

Les étirements doivent être pratiqués **après l'effort uniquement**, jamais à froid avant de courir. Tiens chaque position sans rebonds, en respirant lentement et régulièrement. La régularité quotidienne prime sur l'intensité.



Quadriceps

Face avant de la cuisse

30 sec x 3

Debout sur une jambe, saisir le pied derrière. Genou vers le bas, hanche droite, bassin neutre. Maintiens la position en respirant.



Ischio-jambiers

Face arrière de la cuisse

30 sec x 3

Assis, jambe tendue devant toi, penche le buste vers l'avant en gardant le dos bien droit. Sens l'étirement sous la cuisse.



Mollet et Achille

Mollet et tendon calcanéen

45 sec x 3

Main contre un mur, pied arrière à plat, genou tendu. Pousse le talon vers le sol en contractant légèrement les abdos.



Bandelette IT

Hanche externe

30 sec x 3

Debout, croise les jambes, penche le buste du côté opposé en appuyant la hanche vers l'extérieur. Bras au-dessus.



Fessier piriforme

Fessier profond

30 sec x 3

Allongé, cheville sur genou opposé, tire doucement la cuisse vers la poitrine. Maintiens sans forcer sur la hanche.



Fascia plantaire

Voûte plantaire et talon

60 sec x 2

Assis, saisir les orteils et les tirer vers le tibia. Tenir 30 sec. Masser ensuite la voûte avec une balle de tennis ou de golf.

Règle d'or

Ne jamais s'étirer sur une douleur aiguë. Si une zone est douloureuse, consulte un kinésithérapeute avant de reprendre. La douleur pendant un étirement n'est **jamais normale** et doit alerter immédiatement.

Gestion de la charge

La **surcharge chronique** est la première cause de blessure chez le coureur. Le corps s'adapte si on lui laisse le temps. La règle d'or : n'augmenter qu'un seul paramètre à la fois et planifier la récupération comme une séance à part entière.



Règle des 10%

N'augmente jamais ton volume de plus de 10% par semaine. Applique un cycle 3 semaines de charge / 1 semaine de décharge pour optimiser la surcompensation.



Signaux d'alarme

Un RPE constamment élevé, des douleurs inhabituelles ou une fatigue persistante au réveil sont des signaux d'alarme. Réduire immédiatement la charge avant d'aggraver.



Sommeil = récupération

Moins de 7h de sommeil multiplie par 2 le risque de blessure. Priorise le sommeil autant que l'entraînement : c'est pendant la nuit que le corps se renforce vraiment.



Semaine de décharge

Toutes les 3 à 4 semaines, réduis le volume de 30 à 40%. Cette décharge planifiée déclenche la surcompensation et permet les progrès durables sur la longue durée.

VARIABLES À SURVEILLER ET ÉQUILIBRER

Volume hebdomadaire		70%	+ 10% max / semaine
Intensité des séances		80%	Contrôle via fréquence cardiaque
Fréquence de séances		60%	Augmenter progressivement
Dénivelé positif		45%	Variable souvent négligée
Allure spécifique		35%	Introduire en phase finale
Récupération active		90%	Ne jamais sacrifier le repos

Protocole PEACE & LOVE

Le protocole PEACE & LOVE remplace l'ancien RICE (Repos, Glace, Compression, Élévation). Il intègre les **dernières recherches en médecine du sport** pour une gestion complète et éprouvée des blessures aiguës.

P**Protection**

Limitier les activités douloureuses les 1 à 3 premiers jours. Repos relatif, sans immobilisation totale, pour éviter d'aggraver la lésion.

E**Élévation**

Élever le membre blessé au-dessus du niveau du cœur le plus souvent possible pour réduire l'enflure et accélérer le drainage lymphatique.

A**Anti-inflammatoires : non**

Dans les 72 premières heures, ils freinent l'inflammation naturelle, pourtant essentielle à la cicatrisation. Les éviter sauf prescription médicale.

C**Compression**

Bandage compressif pour limiter l'oedème et soutenir les tissus. Bien serré mais sans couper la circulation : les doigts ne doivent pas bleuir.

E**Éducation**

Comprendre sa blessure pour mieux la gérer. La douleur est un signal utile, pas un ennemi. La reprise progressive est toujours supérieure à l'arrêt total.

L**Loading progressif**

Reprendre la mise en charge dès que possible. Le mouvement contrôlé favorise la guérison et prévient la perte musculaire et de proprioception.

O**Optimisme**

L'état d'esprit positif influence directement la guérison. Les patients optimistes récupèrent plus vite et font moins de rechutes, selon la littérature scientifique.

V**Vascularisation**

Cardio non douloureux (vélo, natation, marche) pour maintenir le flux sanguin, accélérer la cicatrisation et préserver la condition physique.

E**Exercice ciblé**

Reprendre les exercices de renforcement spécifiques dès que possible. La rééducation active est toujours supérieure au repos passif prolongé.

Chaussures et matériel

Le choix de la chaussure est souvent **sous-estimé**, alors qu'il est l'un des facteurs les plus importants dans la prévention des blessures. Une chaussure inadaptée peut créer des problèmes sur toute la chaîne cinétique.

Chaussure d'entraînement daily



Amorti modéré, durabilité maximale. Pour les footings quotidiens. À renouveler tous les 600 à 800 km : les propriétés amorties disparaissent avant que la semelle ne soit usée visuellement. Base indispensable.

Chaussure de vitesse / plaquée



Carbone ou nylon rigide pour les séances intenses et les compétitions. Ne pas utiliser pour les footings quotidiens : le drop très bas et la rigidité entraînent une surcharge tendineuse avérée si l'usage est trop fréquent.

Trail et chaussure de stabilité



Drop bas et semelle adhérente pour le trail. Sur route, la chaussure de stabilité est recommandée en cas de pronation excessive confirmée par un podologue. Elle corrige le valgus sans pour autant rigidifier le pied.

Rotation de 2 à 3 paires



Alternar plusieurs paires différentes réduit de 40% le risque de blessure selon les études. Chaque modèle sollicite différemment le pied et les articulations, permettant une meilleure récupération des tissus entre les sorties.

Bilan podologique régulier



Un bilan biomécanique est conseillé tous les 2 ans ou après une blessure répétée. Des semelles orthopédiques sur-mesure peuvent corriger des déséquilibres structurels qui fragilisent l'ensemble de la chaîne cinétique du bas du corps.

PASSE À L'ACTION

Prêt à courir plus intelligent ?



Tu as maintenant toutes les clés. La prochaine étape : un plan structuré qui respecte tes capacités et te fait progresser sans te blesser.

Nos plans d'entraînement PDF



Plan 10 km
8 semaines

14,99€



Plan 10 km
12 semaines

17,99€



Semi-Marathon
12 semaines

19,99€



Marathon
12 semaines

22,99€



Marathon
16 semaines

24,99€



Guide Anti-Blessure

Tu lis ce guide. Partage-le à un coureur qui en a besoin pour courir plus longtemps.

14,99€



Coaching personnalisé

Plan 100% sur-mesure, suivi hebdomadaire et messagerie directe avec ton coach Alexis.

Disponible sur theultimateacademy.fr

Rejoins The Ultimate Academy

Des centaines de coureurs ont déjà transformé leur entraînement.
C'est ton tour de courir plus loin, plus vite et sans blessure.

theultimateacademy.fr